

Refluxo GE · fisiológico × DRGE

Regurgitação sem sofrimento é fisiológica na maioria dos lactentes. DRGE implica sintomas ou complicações — evite medicar refluxo benigno.

Medidas iniciais

Dica - Medidas iniciais

Espessar seletivamente, volumes menores e mais frequentes, evitar tabaco, manter aleitamento. Elevação do berço tem evidência fraca — cuidado com sono seguro (decúbito dorsal).

Ramificação: tranquilizar e posicionar versus investigar alarme e tratar complicação.



Sinais de alarme

- Vômito bilioso, hemático ou em jato persistente
- Má evolução ponderal, anemia, arquearão com choro (Sandifer)
- Sintomas respiratórios graves / ALTE-BRUE associados
- Início após 6 meses ou piora progressiva — pensar outras causas

Conduta farmacológica

Cenário | Papel

Refluxo fisiológico | Sem IBP/pró-cinético de rotina

Esofagite / DRGE clara | IBP em curso definido

Suspeita de APLV | Teste de exclusão antes de cronificar IBP

Estenose hipertrófica | USG; cirurgia — não é 'refluxo'

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não use IBP empírico prolongado em lactente 'que cuspe'. Vômito bilioso = obstrução até prova em contrário.